

Cycle de préparation au concours de résidanat

SESSION DE DE DECEMBRE 2025

Objectif n°65

**Les syndromes coronariens aigus:
Physiopathologie, diagnostic et
traitement**

TESTS D'AUTO-EVALUATION

Dr Mejdî Ben Messaoud

1) La vascularisation du cœur :

- A) Est assurée par deux artères coronaires
- B) Est de type terminal
- C) Est réalisée en systole ventriculaire
- D) Est meilleure en cas d'augmentation de l'inothérapie
- E) Est meilleure en cas d'augmentation de la fréquence cardiaque

2) Le tronc commun :

- A) Naît du sinus de Valsalva antéro-gauche ventralement par rapport à la coronaire droite
- B) Chemine derrière de l'artère pulmonaire
- C) Est court
- D) Donne trois branches
- E) Peut être absent
- F) A un trajet horizontal

3) L'inter-ventriculaire antérieure :

- A) Est nommée l'artère de la vie
- B) Chemine dans le sillon graisseux interventriculaire antérieur
- C) Contourne le bord droit du cœur près de la pointe
- D) Vascularise la majeure partie des parois du ventricule gauche
- E) Vascularise le ventricule droit par une branche marginale
- F) Donne des branches marginales et septales
- G) Se termine dans la partie inférieure du septum interventriculaire

4) La circonflexe :

- A) Prolonge directement le tronc commun
- B) Chemine dans le sillon atrio-ventriculaire droit
- C) Se dirige vers la face inférieure sans atteindre la croix du cœur
- D) Donne des branches diagonales
- E) Vascularise la paroi antérieure du cœur

5) La coronaire droite :

- A) A une forme en C
- B) Naît du sinus de Valsalva antéro-droit ventralement par rapport à l'artère coronaire gauche
- C) Donne trois branches terminales
- D) Vascularise le nœud sinusal et le nœud auriculo-ventriculaire
- E) Est divisée en 2 segments
- F) Donne précocement une artère conale

6) L'(les) artère(s) qui peu(v) t être coupable(s) d'un IDM antérieur est(sont) :

- A) Le tronc commun
- B) L'IVA
- C) La circonflexe
- D) La coronaire droite
- E) La marginale

7) L'(les) artère(s) qui peu(v)t être coupable(s) d'un IDM inférieur est(sont) :

- A) L'artère coronaire gauche
- B) L'IVA
- C) La circonflexe
- D) La coronaire droite
- E) La marginale

8) Les paramètres qui définissent les besoins du myocarde sont :

- A) L'inotropisme
- B) La fréquence cardiaque
- C) La réduction de la lumière coronaire
- D) La teneur en oxygène du sang artériel
- E) La tension pariétale myocardique

9) La cascade ischémique comprend :

- A) Un métabolisme anaérobie avec production de lactates
- B) Des modifications électriques
- C) Une douleur thoracique
- D) Une altération de la fonction diastolique
- E) Une élévation des biomarqueurs de nécrose

10) Un syndrome coronarien aigu à coronaires saines peut être secondaire à :

- A) Une dissection coronaire
- B) Une cause embolique
- C) Un spasme coronaire
- D) Un takoTsubo
- E) Une aortite syphilitique
- F) Une fibrillation auriculaire
- G) Un rétrécissement aortique
- H) Consommation de cocaïne

11) Une plaque d'athérosclérose vulnérable est caractérisée par :

- A) Un noyau lipidique abondant
- B) Un noyau lipidique de croissance rapide
- C) Un noyau lipidique riche en macrophages
- D) Une chape fibreuse fine
- E) Une chape fibreuse riche en fibres musculaires lisses
- F) L'infiltration par les cellules inflammatoires en tant que principal facteur

12) Les sites d'anti-agrégation plaquettaire qui peuvent être ciblés dans le traitement des syndromes coronariens aigus sont:

- A) Les récepteurs GP IIb/IIIa
- B) Les récepteurs P2Y₁₂
- C) Le facteur vonWillebrand
- D) Le thromboxane A₂
- E) Les cyclooxygénases 2

13) Concernant le syndrome coronarien aigu sans sus décalage persistant de ST :

- A) L'ECG peut être normal
- B) Est défini comme un NSTEMI si les troponines sont positives
- C) L'objectif thérapeutique est la reperfusion en urgence
- D) La coronarographie doit être pratiquée dans les 48 heures
- E) Les troponines sont nécessaires pour confirmer le diagnostic
- F) Réunit l'angor instable et le NSTEMI

14) Les troponines peuvent augmenter dans les circonstances suivantes:

- A) Une insuffisance cardiaque
- B) Une embolie pulmonaire
- C) Une insuffisance hépatique
- D) Un angor instable
- E) Une myocardite aigue
- F) Un état de choc
- G) Un AVC

15) Les diagnostics différentiels d'un SCA ST+ inférieur étendu au VD sont :

- A) Une Embolie pulmonaire massive bilatérale
- B) Une dissection aortique
- C) Une tamponnade
- D) Une pneumopathie basale droite
- E) Un pneumothorax minime apical droit

16) La survenue d'un souffle systolique au cours de l'évolution d'un SCA ST+ est en faveur de :

- A) Une insuffisance mitrale aigue
- B) Une communication interventriculaire
- C) Une tamponnade
- D) Une extension au VD
- E) Une communication inter-auriculaire
- F) Une rupture de la paroi libre du VG
- G) Un obstacle à l'éjection du VG

17) Le traitement à la phase aigüe d'un syndrome coronarien aigu sans sus-décalage persistant de ST à très haut risque ischémique comporte:

- A) La thrombolyse
- B) L'héparine non fractionnée
- C) Un anti GP IIb IIIa
- D) Le Clopidogrel
- E) Le fondaparinux

18) En cas de syndrome coronarien aigu, le clopidogrel:

- A) Est prescrit à la dose de 300 à 600 mg en dose de charge
- B) Est prescrit pendant un an quel que soit le type du stent implanté
- C) Est le traitement de référence pour les inhibiteurs des récepteurs P2Y12
- D) Est un inhibiteur réversible des récepteurs P2Y12
- E) A un délai d'action rapide (10 minutes)
- F) Est une prodrogue qui nécessite une biotransformation hépatique pour libérer son principe actif
- G) Est associé à un risque de saignement plus important que le prasugrel
- H) Est le seul inhibiteur P2Y12 qui peut être prescrit avant une thrombolyse
- I) Est le seul inhibiteur P2Y12 qui peut être prescrit en cas de traitement anticoagulant oral associé

19) Les contre-indications absolues à la thrombolyse en cas de SCA ST+ sont:

- A) AVC hémorragique il y a 20 ans
- B) AVC ischémique il y a 1 an
- C) AVC il y a 10 ans de nature non identifiée à l'interrogatoire
- D) Etat de choc
- E) Une chirurgie abdominale il y a 2 semaines
- F) Une dissection aortique

20) Concernant la thrombolyse indiquée devant un SCA ST+ :

- A) Elle doit être commencée dans les 60 minutes
- B) La streptokinase est le thrombolytique de choix
- C) La survenue d'un RIVA est obligatoire pour définir un succès de thrombolyse
- D) Elle peut être indiquée pour les SCA ST- à très haut risque
- E) Elle doit être évaluée après 60 - 90 minutes pour juger son efficacité

21) La coronarographie est indiquée en urgence en cas de :

- A) SCA ST- avec EDC
- B) SCA ST- avec un score Grace > 140
- C) SCA ST+
- D) SCA ST- avec angor réfractaire
- E) SCA ST- avec modifications électriques sous traitement médical
- F) SCA ST- compliqué d'insuffisance cardiaque congestive
- G) SCA ST- avec troponines très élevées

22) Les critères suivants définissent un SCA ST- à haut risque ischémique:

- A) Un EDC
- B) Un score Grace à 150
- C) Des troponines positives
- D) Des ondes T négatives en inférieur
- E) Des modifications électriques sous traitement médical

23) L'ordonnance de sortie d'un SCA non compliqué chez un patient de 80 ans comporte :

- A) Aspirine 100 mg/j
- B) Ticagrelor 90mg 1 cp x 2/ j
- C) Prasugrel 10mg 1 cp/ j
- D) Atorvastatine 40mg 1 cp/ j
- E) Perindopril 5 mg 1 cp/j

24) Les médicaments suivants peuvent être prescrits en cas de survenue d'un trouble de rythme ventriculaire à la phase aigüe d'un SCA :

- A) Les digitaliques
- B) La dobutamine
- C) Les bêtabloquants
- D) L'amiodarone
- E) La Lidocaine

25) Au cours d'un SCA ST(-), l'ECG peut montrer:

- A) Un sous-décalage du segment ST
- B) Un sus-décalage persistant du segment ST
- C) Des modifications isolées de l'onde T
- D) Aucune modification de ST et de T
- E) Une onde Q de nécrose

26) Les signes de succès de thrombolyse en cas SCA ST+ sont:

- A) Une régression du sus décalage du segment ST
- B) L'apparition d'une onde Q de nécrose
- C) Un pic des marqueurs de nécrose myocardique à 24h du début de la douleur
- D) Une sédation de la douleur thoracique
- E) L'apparition d'un RIVA

27) Après la phase aigüe d'un SCA, la prévention secondaire implique :

- A) Le repos strict pendant une durée de 1 mois
- B) Un objectif de LDL cholestérol $< 0,55$ g/l
- C) Une diminution de la consommation de tabac
- D) Un objectif d'hémoglobine glyquée $< 7\%$ en cas de diabète
- E) L'application des règles hygiéno-diététiques 1 mois après l'IDM

28) Les antiagrégants plaquettaires qui peuvent être prescrits dans les SCA sont :

- A) Aspirine
- B) Tirofiban
- C) Enoxaparine
- D) Clopidogrel
- E) Ticagrolor
- F) Fondaparinux
- G) Bivaluridine

29) L'onde Q de nécrose lors d'un SCA ST+:

- A) Se voit uniquement en cas de nécrose transmurale
- B) Se voit en cas de nécrose transmurale ou sous endocardique
- C) Fait souvent suite à un sous-décalage du segment ST
- D) A une durée de 0.02 secondes
- E) Ne se voit que dans les dérivations précordiales

30) Un SCA ST+ antérieur compliqué d'un état de choc primaire se manifeste par les signes suivants:

- A) Une turgescence des veines jugulaires
- B) Une fréquence cardiaque à 110 bpm
- C) Un pouls radial imprenable ou filant
- D) Un pouls paradoxal
- E) Des râles crépitants diffus à l'auscultation pulmonaire

31) Le diagnostic électrique du SCA ST+ peut être masqué par :

- A) Un bloc de branche gauche complet
- B) Un pace maker
- C) Une fibrillation auriculaire
- D) Un BAV
- E) Une hypertrophie ventriculaire gauche

32) La survenue d'une salve de rythme idio-ventriculaire accéléré (RIVA) à la phase aiguë d'un SCA ST+:

- A) Est un élément de mauvais pronostic
- B) Impose un traitement anti-arythmique systématique
- C) Est une indication de traitement par atropine
- D) Nécessite un choc électrique externe
- E) Nécessite une simple surveillance

33) Les complications mécaniques du SCA ST+ sont :

- A) Une communication inter ventriculaire
- B) Un état de choc primaire
- C) Une insuffisance mitrale aiguë
- D) Un bloc auriculo ventriculaire complet
- E) Une tachycardie ventriculaire

34) L'apparition d'un souffle systolique à la 48ème heure d'évolution d'un SCA ST+ inférieur doit faire évoquer :

- A) Une extension au ventricule droit
- B) Une insuffisance tricuspidiennne aiguë
- C) Une insuffisance mitrale aiguë par rupture de pilier
- D) Une communication inter-auriculaire
- E) Une communication inter-ventriculaire

35) En cas d'un SCA ST+ inférieur étendu au VD, les médicaments suivants sont contre indiqués :

- A) Un remplissage par Plasmagel
- B) Les dérivés nitrés
- C) Les diurétiques
- D) La dobutamine
- E) Les bêtabloquants
- F) Les IEC

36) La stratification du risque au cours d'un SCA ST- :

- A- Implique des critères cliniques
- B- Distingue 3 niveaux de risque
- C- Est une étape obligatoire à la sortie du patient
- D- Permet d'adapter le traitement antithrombotique selon le niveau de risque
- E- Définit un risque élevé en cas de score GRACE > 140

37) Les paramètres inclus dans le calcul du score GRACE sont :

- A- L'âge
- B- L'élévation des troponines
- C- La fréquence cardiaque
- D- L'insuffisance cardiaque
- E- Le diabète

38) Le score Grace estime le risque de :

- A- La mortalité intra-hospitalière
- B- La mortalité à 6 mois
- C- La mortalité ou IDM à 6 mois
- D- IDM à 12 mois
- E- La mortalité à 12 mois

39) Le traitement anti-ischémique des SCA comporte :

- A) Les bêtabloquants
- B) Les inhibiteurs calciques de type dihydropiridine
- C) Les dérivés nitrés
- D) Les IEC
- E) Les statines

40) Les thrombolytiques dérivés de l'activateur tissulaire du plasminogène sont :

- A) La ténecteplase
- B) La rétéplase
- C) L'altéplase
- D) La streptokinase
- E) L'urokinase

41) La prescription du prasugrel dans les SCA est contre indiquée en cas de :

- A) Antécédent d'AVC ischémique
- B) Antécédent d'AVC hémorragique
- C) Age > 60 ans
- D) Poids < 60 Kg
- E) Etat de choc

42) En cas de décision de thrombolyse d'un SCA ST+, les médicaments suivants ne peuvent pas être prescrits avant la thrombolyse :

- A) Prasugrel
- B) Clopidogrel
- C) Ticagrelor
- D) Héparine non fractionnée
- E) HBPM

43) La survenue d'une péricardite aigue 48 heures après un SCA ST+ :

- A) Est définie par le syndrome de Dressler
- B) Est secondaire à un mécanisme inflammatoire
- C) Doit être traitée par des corticoïdes
- D) Est souvent transitoire
- E) Est associée à un syndrome infectieux sévère avec des arthralgies

44) La thrombolyse indiquée devant un infarctus du myocarde :

- A) Doit être commencée dans les 60 minutes
- B) Peut être administrée à moitié dose si l'âge est avancé
- C) Son succès ou échec doit être jugé au plus tard 60 mn après le début de thrombolyse
- D) La survenue d'un rythme idio-ventriculaire accéléré (RIVA) est obligatoire pour définir un succès de thrombolyse
- E) Peut être indiquée pour les syndromes coronariens aigus sans sus-décalage du segment ST à très haut risque ischémique
- F) Est contre indiquée en cas de survenue d'un état de choc

45) Une coronarographie devrait être faite dans les 2 heures suivant la prise en charge d'un SCA ST (-) en cas de :

- A) Une arythmie menaçant le pronostic vital ou arrêt cardiaque
- B) Instabilité hémodynamique ou choc cardiogénique
- C) Une troponine positive
- D) Douleurs thoraciques réfractaires au traitement médical
- E) Un score de GRACE à 152

46) Le prasugrel :

- A) Est un inhibiteur irréversible des récepteurs P2Y12
- B) Est une prodrogue qui nécessite un métabolisme hépatique
- C) A un effet antiaggrégant plus puissant que le clopidogrel
- D) A un délai d'action plus rapide que le ticagrelor
- E) A des interactions médicamenteuses plus fréquentes que le clopidogrel

47) L'anticoagulant à prescrire de première intention en cas d'angioplastie primaire est :

- A) L'héparine non fractionnée
- B) L'Enoxaparine
- C) La bivalirudine
- D) Le fondaparinux
- E) L'apixaban

48) La survenue d'un BAV à la phase aigüe d'un SCA ST+ :

- A) Est plus fréquente en cas de SCA ST+ inférieur
- B) Est de plus mauvais pronostic en cas de SCA ST+ antérieur
- C) Est due à une nécrose du faisceau de His en cas de SCA ST+ inférieur
- D) Est souvent bien tolérée en cas de SCA ST+ inférieur
- E) Nécessite la mise en place d'une sonde de stimulation dans tous les cas

49) Le traitement antithrombotique recommandé avant de commencer une thrombolyse peut comporter :

- A) Clopidogrel 300 mg
- B) Prasugrel 60 mg
- C) Héparine non fractionnée 60 UI/Kg en bolus iv
- D) Enoxaparine 30 mg bolus iv
- E) Ticagrelor 180 mg

50) Les critères d'une implantation d'un défibrillateur implantable en prévention primaire d'un SCA :

- A) A partir de 6 à 8 semaines post-infarctus
- B) Si FEVG $\leq 35\%$ malgré un traitement optimal est une revascularisation complète
- C) Si l'espérance de vie est supérieure à 12 mois
- D) En cas de persistance de trouble de rythme ventriculaire au-delà de 48 heures post IDM
- E) En cas de survenue d'une tachycardie ventriculaire à la phase aigüe du SCA

51) Le prétraitement par un inhibiteur P2Y12 n'est pas indiqué dans les situations suivantes :

- A) STEMI avec indication d'angioplastie primaire
- B) STEMI avec indication de thrombolyse
- C) NSTEMI avec EDC
- D) NSTEMI compliqué d'une TV
- E) NSTEMI avec angor réfractaire sous traitement médical

Cas cliniques :

Cas clinique n°1 :

Un patient âgé de 50 ans, diabétique, non coronarien connu mais sous aspirine depuis 10 ans indiquée en prévention primaire, admis pour trois épisodes de douleur angineuse au repos de durée 15 mn, survenant les dernières 24 heures.

L'examen physique est sans particularités. L'ECG montre un sous décalage de ST et des ondes T négatives dans territoire antérieur. Le dosage des troponines est revenu positif.

1) Quel est votre diagnostic ?

- A) Angor instable
- B) Angor Prinzmetal
- C) NSTEMI
- D) STEMI
- E) Angor stable

2) Quels sont les autres facteurs de risque cardiovasculaires modifiables à identifier dans l'interrogatoire ?

- A) Le tabac
- B) L'hérédité coronaire
- C) L'hypercholestérolémie
- D) L'hyperthyroïdie
- E) L'HTA

3) Quel serait le niveau du risque ischémique chez ce patient?

- A) Très haut
- B) Haut
- C) Intermédiaire
- D) modéré
- E) Non haut

4) Quelle est à votre avis l'artère coupable de cette symptomatologie ?

- A) IVA
- B) Circonflexe
- C) Marginale
- D) Coronaire droite
- E) IVP

5) Quel est le délai nécessaire pour réaliser la coronarographie ?

- A) 24 heures
- B) 2 heures
- C) 48 heures
- D) 72 heures
- E) 12 heures

Cas clinique n°2 :

Patient âgé de 75 ans, tabagique, consulte pour douleur thoracique suivie d'une agitation.

L'examen physique trouve un patient algique, une pression artérielle imprenable et une turgescence des jugulaires. L'ECG met en évidence un sus-décalage de ST en DII DIII AVF.

1) Quels sont les diagnostics probables ?

- A) IDM inférieur étendu au VD
- B) Embolie pulmonaire massive
- C) IDM inférieur compliqué de tamponnade
- D) IDM inférieur compliqué d'insuffisance mitrale aigue
- E) IDM inférieur compliqué de BAV

2) Quelle est l'artère coupable à votre avis ?

- A) L'IVA
- B) L'artère coronaire gauche
- C) L'artère diagonale
- D) La circonflexe
- E) La coronaire droite

3) Quelles sont les autres complications auxquelles le patient est fortement exposées ?

- A) Une CIV
- B) Une IM aigue
- C) Un BAV
- D) Une insuffisance aortique
- E) Une rupture de la paroi libre du VG

4) Quelle serait votre conduite en urgence ?

- A) Remplissage
- B) Angioplastie primaire
- C) Dérivés nitrés
- D) Diurétiques
- E) IEC

Cas clinique n°3 :

Un patient âgé de 60 ans, tabagique, consulte pour douleur thoracique prolongée depuis 6 heures.

Le diagnostic de SCA ST+ est suspecté et l'ECG a été réalisé.

1) Dans quel délai faut-il pratiquer l'ECG ?

- A) 10 minutes
- B) 5 minutes
- C) 30 minutes
- D) 60 minutes
- E) 20 minutes

2) Le diagnostic de SCA ST+ antérieur a été retenu. L'ECG dans ce cas peut montrer:

- A) Une onde T pointue ample et symétrique en antérieur
- B) Une onde Q de nécrose en DII DIII AVF
- C) Un sous décalage de ST en V1V2V3
- D) Un sous décalage de ST en DII DIII AVF
- E) Un sus-décalage de ST diffus et concave en haut

Juste après la réalisation de l'ECG, le patient a présenté une perte de conscience. L'examen trouve une pression artérielle imprenable et une tachycardie à 200 bpm.

3) Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A) Une tamponnade
- B) Une rupture de la paroi libre du VG
- C) Une insuffisance mitrale aiguë
- D) Une tachycardie ventriculaire
- E) Une extension au ventricule droit

4) Quelle est votre conduite en urgence ?

- A) Drainage péricardique
- B) Remplacement valvulaire mitral
- C) Choc électrique externe
- D) Cordarone 300 mg en iv
- E) Un remplissage

Cas clinique n°4 :

Patiente âgée de 66 ans, hypertendue et diabétique, consulte pour douleur thoracique évoluant depuis 4 heures avec survenue d'un épisode de perte de connaissance.

L'examen trouve une patiente algique, une TA à 150/80 bpm et une FC à 35 bpm.

L'ECG montre une dissociation auriculo-ventriculaire complète avec un sus décalage de ST en DII DIII AVF et un sous décalage de ST en V1V2V3.

1) Quel est votre diagnostic ?

- A) SCA ST+ inférieur compliqué de BAV complet
- B) SCA ST+ inférieur compliqué de tachycardie ventriculaire
- C) SCA ST+ inférieur étendu au VD
- D) SCA ST+ inférieur compliqué de fibrillation auriculaire
- E) SCA ST+ inférieur compliqué de fibrillation ventriculaire

2) Quelle serait l'artère coupable à votre avis?

- A) La circonflexe
- B) L'IVA
- C) L'IVP
- D) La coronaire droite
- E) Le tronc commun

3) Quelle serait votre conduite thérapeutique en urgence?

- A) Choc électrique externe
- B) Amiodarone 300 mg en IV
- C) Lidocaïne en IV
- D) Atropine IV
- E) Massage cardiaque externe

Cas clinique n°5 :

Patient âgé de 60 ans, tabagique, aux antécédents d'AVC ischémique il y a 3 mois, consulte pour douleur thoracique depuis 8 heures avec une dyspnée brutale.

Examen : Patient algique, TA 80/60 mmHg, FC 118 bpm, cépitants diffus et souffle systolique cardiaque.

ECG : RRS, sus-décalage de ST en DII DIII AVF.

1) Quel est votre diagnostic ?

- A) SCA ST+ inférieur compliqué de CIV
- B) SCA ST+ inférieur étendu au VD
- C) SCA ST+ inférieur compliqué d'IM aigue
- D) SCA ST+ inférieur compliqué de tamponnade
- E) SCA ST+ inférieur compliqué d'IVG killip III

2) Quelle serait l'artère coupable à votre avis ?

- A) La circonflexe
- B) L'IVA
- C) La marginale du bord droit du cœur
- D) La coronaire droite
- E) Le tronc commun

3) Quel autre examen complémentaire demandez-vous en urgence pour conforter votre diagnostic?

- A) Un angioscanner aortique
- B) Une échographie cardiaque transthoracique
- C) Une radiographie de thorax
- D) Un ECG complet 18 dérivationes
- E) Une échographie cardiaque trans-oesophagienne

4) Votre conduite en urgence comporte :

- A) Une assistance circulatoire hémodynamique
- B) L'administration de la dobutamine
- C) Un remplissage
- D) Une coronarographie
- E) Une fibrinolyse

Cas clinique n°6:

Un homme âgé de 62 ans, diabétique et ayant une hypercholestérolémie consulte en urgence pour une douleur thoracique de repos constrictive durant 20 minutes. L'examen clinique objective une tension artérielle à 160/90mmHg, une fréquence cardiaque à 70 bpm, une auscultation cardiaque et pulmonaire normales et l'abolition du pouls pédieux droit. L'ECG montre un rythme sinusal avec un sous décalage de ST de 2 mm de V1 à V6. L'indice de Sokolow est à 40 mm. Les troponines sont positives. Le diagnostic de syndrome coronarien aigu sans sus décalage de ST est retenu.

1) Le traitement d'urgence va comporter :

- A) Une héparinothérapie préférentiellement par l'héparine non fractionnée
- B) Deux antiagrégants plaquettaires à base d'anti glycoprotéine 2b3a et d'acide acétyl salicylique
- C) Une insulinothérapie si la glycémie au doigt est élevée
- D) Une statine à forte dose
- E) Un bêtabloquant

2) Une coronarographie sera réalisée :

- A) A distance de l'épisode aigu, après équilibre glycémique et tensionnel
- B) Après hydratation intraveineuse pendant 3 jours pour éviter une néphropathie au produit de contraste iodé
- C) En extrême urgence si apparition de modifications électriques sous traitement médical
- D) Dans les 24 heures vu le risque ischémique élevé chez ce patient
- E) Après évaluation de l'étendue de l'ischémie myocardique par une scintigraphie myocardique

3) La prévention secondaire chez ce patient :

- A) Est à instaurer dès la première diététique
- B) Sera médicamenteuse et hygiéno diététique
- C) Diminue le risque de récurrence d'infarctus et améliore sa qualité de vie
- D) Devra être appliquée pendant 12 mois après le syndrome coronarien aigu
- E) Visera une hémoglobine glyquée inférieure à 7% et un LDL cholestérol inférieur à 0.55g/l

Bonne chance ☺